

Esclerite

Conceito

Condição inflamatória ocular grave que afeta a esclera;

→ Classificação:

- Anterior
 - Difuso
 - Nodular
 - Necrosante
 - Posterior
 - Difuso
 - Nodular
- Etiologias:
- Idiopáticas;
 - Infecciosas;
 - Vírus;
 - Bactérias;
 - Fungos
 - Não-infecciosas;
 - Medicamentos;
 - Bifosfonatos;
 - Doenças autoimunes;
 - Cirurgias;
 - Remoção de ptirígio;
 - Cerclagem escleral;

Quadro Clínico

 Quadro clínico (isso diferencia de cara)

- *dor intensa, profunda, irradiada* (mandíbula, face, têmpora)
- piora com movimento ocular
- pode acordar o paciente à noite
- olho vermelho (mais violáceo)
- ↓ acuidade visual (pode ter)

Anterior

- Anterior à inserção do músculo reto no limbo
- Ocorre em 98% dos casos.
- Dor e sensibilidade leves a moderadas; pior à noite.
- **Dor ao movimentar os olhos**
- Tonalidade azul-violeta dos vasos sanguíneos profundos; melhor visualizada à luz do dia ou sob iluminação natural.



-
- Fotofobia, lacrimejamento e possível diminuição da visão.
- Não ocorre branqueamento dos vasos com a aplicação tópica de fenilefrina a 2,5%.

Difuso

- Mais comum (45% a 61%)
- Edema escleral extenso; congestão de vasos profundos e superficiais.
- Pode ser localizada ou abranger toda a esclera anterior.

Nodular

- Nódulos múltiplos, bem definidos e imóveis.
- Edema escleral e congestão vascular.
- Geralmente mais localizado



Necrotizante

- Com inflamação – congestão intensa dos vasos sanguíneos
- dor intensa
- Forma mais grave com o pior prognóstico
- Maior associação com doença sistêmica
- Possibilidade de afinamento da esclera e exposição da coroide
- A inflamação pode se espalhar para outros tecidos oculares, como a córnea, o corpo ciliar ou a malha trabecular.

Necrotização sem inflamação (Escleromalácia perforante)

- Afinamento escleral grave - com coroide visível
- Pode ser assintomático ou apresentar acuidade visual reduzida resultante do astigmatismo corneano causado pelo afinamento da esclera.

Posterior

- Pode ocorrer em conjunto com esclerite anterior.
- Pode apresentar-se com diminuição da visão, com ou sem dor ocular.
- Descolamentos de retina, edema do nervo óptico e manchas algodonosas podem ser observados no exame com dilatação da pupila.
- Os subtipos difuso ou nodular podem ser diferenciados por meio de tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM).

Diferença chave vs episclerite

	Episclerite	Esclerite
Dor	leve	intensa
Profundidade	superficial	profunda
Cor	vermelho vivo	violáceo
Gravidade	benigna	potencialmente grave

Teste útil (quando dá pra fazer)

- Fenilefrina tópica:
 - episclerite → vasos clareiam
 - esclerite → **não clareia**

Associação importante

Sempre pensar em:

- artrite reumatoide
- vasculites (ex: granulomatose)
 - 👉 Aqui tem doença sistêmica até prova em contrário

Tratamento

- Analgesia;
- AINE sistêmico;
-